

	โรงพยาบาลปากช่องนานา แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)		จำนวน.....หน้า
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วย Acute Gastroenteritis	หน่วยงานที่ใช้ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม	
	รหัสเอกสาร CNPG-AGE	วันที่เริ่มใช้	
หน่วยงาน : กุมารเวชกรรม		ผู้จัดทำ : (นางสาวอารียา เอกทวีกุล) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ	
ผู้ทบทวน (นางสาวนราวดี ปุ่สูงเนิน) ตำแหน่ง : หัวหน้าพยาบาล		ผู้อนุมัติ : (นายแพทย์สกล ด่านภักดี) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่อง นานา	

ประวัติการแก้ไข
หน้า

[illegible]

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า1/.....
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วย Acute Gastroenteritis	รหัสเอกสาร CNPG-.....

สารบัญ

หน้า

1. วัตถุประสงค์
2. เป้าหมายของการใช้
3. พยาธิสภาพของโรค
4. นิยามศัพท์เฉพาะ
5. แนวทางการดูแลรักษาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
6. วิธีดำเนินการ
 - 6.1 Flow chart ระบบงาน
 - 6.2 ขั้นตอนแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก
 - 6.3 รายละเอียดขั้นตอนขั้นตอนแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก
 - 6.4 จำนวนพยาบาลที่ใช้
 - 6.5 แนวทางการจัดสรรทรัพยากร
7. การบันทึกข้อมูลและเอกสารที่ใช้ (Records & Form)
 - 7.1 การบันทึกการใช้ CNPG ในระบบ KPHIS
 - 7.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
8. เอกสารอ้างอิง (หรือ References) ตาม APA6th พร้อมเขียนอ้างอิงในเอกสาร
9. ภาคผนวก

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า 1/.....
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วย Acute Gastroenteritis	รหัสเอกสาร CNPG-.....

การพยาบาลผู้ป่วย Acute Gastroenteritis

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กที่ป่วยโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลัน ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
- เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลัน หอผู้ป่วย

กุมารเวชกรรม

2. ลักษณะกลุ่มผู้ป่วย

ครอบคลุมผู้ป่วยเด็กที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลัน (Acute Gastroenteritis) ที่อยู่ในช่วงอายุ 1 เดือน ถึงช่วงอายุไม่เกิน 15 ปี ที่เข้ารับการรักษานในหอผู้ป่วย
กุมารเวชกรรม

3. พยาธิสภาพของโรค

โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลัน (Acute Gastroenteritis)

พยาธิสภาพ

โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลัน เกิดจากการเคลื่อนที่และการสร้างน้ำและอิเล็กโทรลัยต์ในลำไส้ผิดปกติ กลไกเกิดจากความดันออสโมติก (osmotic) ในลำไส้ การบุกรุกของเชื้อ (pathogens) การปล่อยพิษของเชื้อในลำไส้ (enterotoxin หรือ cytotoxin) การบุกรุกของเชื้อในทางเดินอาหารหรือพิษของเชื้อในลำไส้ ทำให้เกิดการหลั่งและลดการดูดซึมของลำไส้ รวมทั้งทำให้ลำไส้ถูกทำลาย เกิดการอักเสบ ไวรัสที่เป็นสาเหตุจะทำอันตรายเซลล์ที่พัฒนาเต็มที่แล้ว ตรงยอดของวิลไล (villi) ของเยื่อบุลำไส้ ทำให้มีการสลายตัวของเซลล์ตายหลุดไป จะเกิดกับเยื่อบุลำไส้ที่ดูโอดีนัมก่อน แล้วลุกลามลงมาตลอดลำไส้เล็ก ทำให้เกิดการติดเชื้อทั่วทั้งลำไส้ภายในเวลา 24 ชั่วโมง

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า 1/.....
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วย Acute Gastroenteritis	รหัสเอกสาร CNPG-.....

พยาธิสรีรภาพของโรค เกิดขึ้นเมื่อเชื้อสัมผัสกับเยื่อบุลำไส้ แต่ไม่รุกรานกลับปล่อยพิษออกมา หรือได้รับพิษจากภายนอก เช่น อาหาร ทำให้เกิดน้ำในโพรงลำไส้มากขึ้น จากการหลั่ง และการดูดซึมกลับน้ำของลำไส้เสียไป เกิดภาวะอุจจาระร่วงจากภาวะหลังเกิน (secretory diarrhea) ซึ่งพบได้บ่อยรุนแรงและเฉียบพลันจากการขาดน้ำ (dehydration) ภาวะเป็นกรด (acidosis) และช็อกได้เมื่อขาดสารน้ำอย่างรุนแรง แต่ถ้าเชื้อรุกรานเข้าไปในเซลล์เยื่อเมือกหรือเซลล์เยื่อบุในลำไส้เรียกภาวะอุจจาระร่วงแบบแพร่กระจาย (invasive diarrhea) หรืออุจจาระร่วงแบบบิด (dysenteric diarrhea) เกิดขึ้นที่ลำไส้เล็กส่วนปลายหรือลำไส้ใหญ่ มีการอักเสบ การทำลายของเซลล์ทำให้เซลล์แตก มีเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นในบริเวณเยื่อบุลำไส้และชั้นลึกลงไป มีการลอกหลุดของเซลล์ เกิดเป็นแผลหย่อมๆ มีอาการ ปวดถ่ายปวดเบ่ง อุจจาระมีมูกเลือด

สาเหตุ

1. การติดเชื้อ พบร้อยละ 70 เชื้อที่ทำให้เกิดโรคมีหลายชนิด เช่น ไวรัส แบคทีเรีย ทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้ถูกรบกวน เกิดการอักเสบของ กระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก (gastroenteritis) หรือการอักเสบของลำไส้เล็ก (enteritis) หรือทั้งลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ (enterocolitis)

2. เกิดจากการดูดซึมผิดปกติ (malabsorption syndrome) เนื่องจากลำไส้ถูกตัดสั้น ขาดสารอาหาร ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (immune deficiency) การแพ้อาหาร (food allergy) การขาดน้ำย่อยแลคโตส (lactose intolerance) หรือเกิดการระคายเคืองในลำไส้ (irritable diarrhea) จากการได้รับน้ำผลไม้จำนวนมาก น้ำหวานเข้มข้น การได้รับสารพิษ เช่น ตะกั่ว

อาการสำคัญ ได้แก่ ถ่ายอุจจาระเหลว/ถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือด อาเจียน ชีพจร

อาการโดยทั่วไป

ผู้ป่วยขาดน้ำเล็กน้อย (mild dehydration) มีการขาดน้ำน้อยกว่าร้อยละ 3-5 ของน้ำหนักตัว จะมีอาการกระหายน้ำเล็กน้อยริมฝีปากแห้งเล็กน้อย

ผู้ป่วยขาดน้ำปานกลาง (moderate dehydration) มีการขาดน้ำร้อยละ 6-9 ของน้ำหนักตัว จะสูญเสียความตึงตัวของผิวหนัง (skin turgor) ผิวหนังจับตัวได้ และริมฝีปากแห้ง

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า 1/.....
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วย Acute Gastroenteritis	รหัสเอกสาร CNPG-.....

ผู้ป่วยขาดน้ำรุนแรง (severe dehydration) มีการขาดน้ำมากกว่าร้อยละ 10 ของน้ำหนักตัว จะมีอาการอ่อนเพลียมาก ไม่รู้สึกตัว ผิวหนังจับตึงได้นานกว่า 2 วินาที มือเท้าเย็นระยะเวลาการกำซาบของหลอดเลือดฝอย (capillary refill time) ลดลง พบว่ามีอาการหายใจหอบลึก (อาการของภาวะเลือดเป็นกรด) ไม่ปัสสาวะนานกว่า 6 ชั่วโมง แสดงถึงจำนวนเลือดไปเลี้ยงไตที่ลดลง บอกถึงภาวะขาดน้ำในระยะแรกได้ดีกว่าอาการกระหม่อมบวมและการไม่มีน้ำตา

การวินิจฉัย

1. การซักประวัติ ในผู้ป่วยเด็ก ประวัติที่ได้จะได้รับจากมารดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก การซักวันที่เริ่มมีอาการรุนแรง จำนวนครั้งที่ถ่ายแต่ละวัน ปริมาณอุจจาระที่ถ่ายแต่ละครั้ง ลักษณะอุจจาระแต่ละวัน (เหลว เป็นน้ำ มีมูกเลือด) ระยะเวลาที่เป็น มีไข้หรือไม่ ปวดท้อง อาเจียนหรือไม่ รับประทานอาหารชนิดประเภทอะไร การผสมอาหาร การผสมนม การเตรียมเป็นอย่างไร การเปลี่ยนอาหาร มีการเดินทาง สถานที่อยู่ สถานเลี้ยงเด็ก แหล่งน้ำสะอาด การดูแลเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคล การสัมผัสสัตว์เลี้ยงหรือนก การได้รับยาปฏิชีวนะ

2. การตรวจร่างกาย เช่น สัญญาณชีพ ความดันโลหิต ความตึงตัวของผิวหนัง ปากแห้ง ริมฝีปากแห้ง

ตาโหล กระหม่อมหน้าบวม การชั่งน้ำหนัก การวัดส่วนสูง การประเมินการขาดน้ำ

3. การตรวจอุจจาระ stool examination, rectal swab culture

4. การตรวจเลือด ส่งตรวจเพื่อตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (complete blood count) ค่าอิเล็กโทรไลต์และ BUN

5. การตรวจปัสสาวะ เพื่อวิเคราะห์ค่าต่าง ๆ ในปัสสาวะ และความถี่จำเพาะของปัสสาวะ

การรักษา

1. การให้สารน้ำทางปาก (oral rehydration therapy)

ขนาดและวิธีการให้ ORS แนะนำให้ใช้ ORS เพื่อทดแทนภาวะขาดน้ำในปริมาณ 50 มล./กก. ใน 4 ชั่วโมง สำหรับเด็กที่มีระดับการขาดน้ำน้อย และ 100 มล./กก. ใน 4 ชั่วโมง สำหรับเด็กที่มีระดับการขาดน้ำปานกลาง โดยให้ผู้ดูแลค่อย ๆ ให้ ORS แก่เด็กในปริมาณน้อย ๆ แต่บ่อย ๆ โดยอาจใช้ช้อนตักป้อนทุก 1 นาที เพื่อลดอาการอาเจียน และทำให้เด็กคุ้นเคยต่อรสชาติของ ORS เมื่อให้สารน้ำเพื่อทดแทนการขาดน้ำเรียบร้อยแล้ว สามารถให้กินอาหารหรือดื่มนมได้ตามปกติ และ แนะนำให้ ORS ทดแทน con-current loss 10 มล/กก. ต่อการถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำ 1 ครั้ง (ปริมาณสูงสุด 240 มล. ต่อครั้ง) ใน 1-3 วันแรก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการขาดน้ำขึ้นมาใหม่

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า1/.....
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วย Acute Gastroenteritis	รหัสเอกสาร CNPG-.....

2. การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (intravenous rehydration therapy)

1) ผู้ป่วยที่มีภาวะช็อก ในรายที่มีภาวะช็อก ให้ normal saline solution หรือ lactated Ringer's solution 20 มล./กก. ทางหลอดเลือดดำภายใน 10-15 นาที หากความดันเลือดยังไม่ปกติให้พิจารณาให้ซ้ำอีก 1-2 ครั้ง และเมื่อความดันเลือดกลับมาปกติ ให้แก้สารน้ำทางหลอดเลือดดำต่อตามวิธีการแก้ไขภาวะขาดน้ำระดับรุนแรง หากระดับความดันเลือดของผู้ป่วยไม่ดีขึ้นหลังให้สารน้ำครั้งที่ 2-3 (หรือปริมาณ 60 มล./กก) แล้วควรพิจารณาสาเหตุอื่นของภาวะช็อกด้วย

2) ผู้ป่วยที่มีภาวะขาดน้ำรุนแรงที่ไม่มีภาวะช็อก แนะนำให้สารน้ำเท่ากับ maintenance รวมกับ deficit ($\% \text{ deficit} \times 10 \times \text{น้ำหนักตัว}$) โดยการ initial hydration ด้วย normal saline solution หรือ lactated Ringer's solution ในปริมาณ 10-20 มล/กก/ชั่วโมง เป็นเวลา 2-4 ชั่วโมง และแก้ deficit ที่เหลือต่อจนครบ 24 ชั่วโมงโดยหักปริมาณสารน้ำที่ให้ไปแล้วออก

3. Nutritional management

โดยทั่วไปแนะนำให้ทานอาหารตามวัย และเป็นอาหารอ่อน ย่อยง่าย ซึ่งจะทำให้ได้รับอาหารได้ดีขึ้นในช่วงที่มีอาการท้องร่วง โดยให้ทานในปริมาณน้อย ๆ และบ่อย ๆ เพื่อลดอาการอาเจียน ไม้มีความจำเป็นต้องงดอาหาร ยกเว้น เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เนื่องจากอาจทำให้ท้องร่วงมากขึ้น

การพยาบาล

1. ประเมินภาวะขาดน้ำ โดยการชั่งน้ำหนักเด็กทุกวัน ตวงปัสสาวะ วัดความถี่ของปัสสาวะ ตรวจดูอาการ ดูแลการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถรับทางปากได้

2. ระวังระวังในการแพร่กระจายเชื้อก่อนและภายหลังสัมผัสเด็ก หรือให้การพยาบาลเด็กต้องล้างมือ ทำความสะอาดบริเวณที่เด็กอยู่ เช่น ห้องนอน เตียง อ่างอาบน้ำ ของเล่น ภาชนะบรรจุอาหารให้สะอาด แห้งอยู่เสมอ ผ้าอ้อมหรือผ้าที่สัมผัสอุจจาระที่ต้องชั่งน้ำหนักเพื่อประเมินการถ่ายอุจจาระ ระวังระวังเก็บในที่ที่ไม่แพร่กระจายเชื้อ

3. การถ่ายอุจจาระบ่อยทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ควรทำความสะอาดอย่างเบามือ นุ่มนวล ทา zinc oxide ให้ ไม่วัดปรอททางทวารหนัก

4. ให้การช่วยเหลือ หรือดูแลเด็กและผู้ปกครอง เหมือนกับผู้ป่วยคนอื่นๆ ในโรงพยาบาล และแนะนำเป็นการเฉพาะในเรื่องการให้อาหาร การล้างมือ การเก็บสิ่งปฏิกูลของเด็กเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า1/.....
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วย Acute Gastroenteritis	รหัสเอกสาร CNPG-.....

เภสัชวิทยา

1. *Ceftriaxone* สรรพคุณ รักษาการติดเชื้อในกระแสเลือดและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ เช่น *E. coli*, *Pseudomonas*, *Klebsiella*, *H. influenza* บทบาทพยาบาล ทดสอบการแพ้ยาก่อนให้ บันทึกสัญญาณชีพก่อนและหลังให้ยา สังเกตอาการผื่นแดงตามตัว อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ติดตามภาวะตับและ ไตอักเสบ
 2. *Motilium* สรรพคุณ รักษาอาการจุกเสียด แน่นหน้าอก คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด แน่นท้อง บทบาทพยาบาล สังเกตอาการข้างเคียงของยา เช่น อาการปวดศีรษะ ปวดท้อง ปากแห้ง
 3. *Domperidone* ยาออกฤทธิ์เป็น dopamine D2 and D3 receptor antagonist มีผลด้านการอาเจียนโดยยับยั้งตัวรับที่ chemoreceptor trigger zone บริเวณ fourth ventricle ของสมองนอกจากนี้ยังออกฤทธิ์ทำให้การบีบตัวของทางเดินอาหารส่วนต้นเพิ่มขึ้น
 4. *Metoclopramide* ยาออกฤทธิ์เป็น dopamine D2 receptor antagonist ทำให้การบีบตัวของทางเดินอาหารส่วนต้นบริเวณกล้ามเนื้อหูรูดของหลอดอาหารส่วนปลาย gastric antrum และ duodenum เพิ่มขึ้น
4. นิยามศัพท์เฉพาะ
- 4.1 ผู้ป่วยเด็ก หมายถึง ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
 - 4.2 โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลัน หมายถึง ภาวะการอักเสบของกระเพาะอาหาร และลำไส้ มีการถ่ายอุจจาระมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ครั้งต่อวัน หรือถ่ายเป็นมูกเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือถ่ายเป็นน้ำปริมาณมากเพียงครั้งเดียว โดยเกิดในระยะเวลา 24 ชั่วโมง และไม่เกิน 2 สัปดาห์

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า1/.....
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วย Acute Gastroenteritis	รหัสเอกสาร CNPG-.....

5. แนวทางการดูแลรักษาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (หรือ Associated document)

- แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคท้องร่วงเฉียบพลันในเด็ก Clinical Practice Guideline for Acute Diarrhea in Children. สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ. (2562)
- ผลของการพยาบาลอย่างต่อเนื่องต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันของผู้ดูแล. คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พัชรพร คำภูมิ. (2564)

กำหนดกรอบและวัตถุประสงค์ของการสืบค้น

การสืบค้นงานวิจัยใช้การกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักฐาน โดยใช้แนวคิด PICO Framework ระบุคำสำคัญตามรายละเอียดดังนี้

P (Populations) – ผู้ดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 0-15 ปี โรคกะเพาะและลำไส้อักเสบเฉียบพลัน

I (Interventions) –

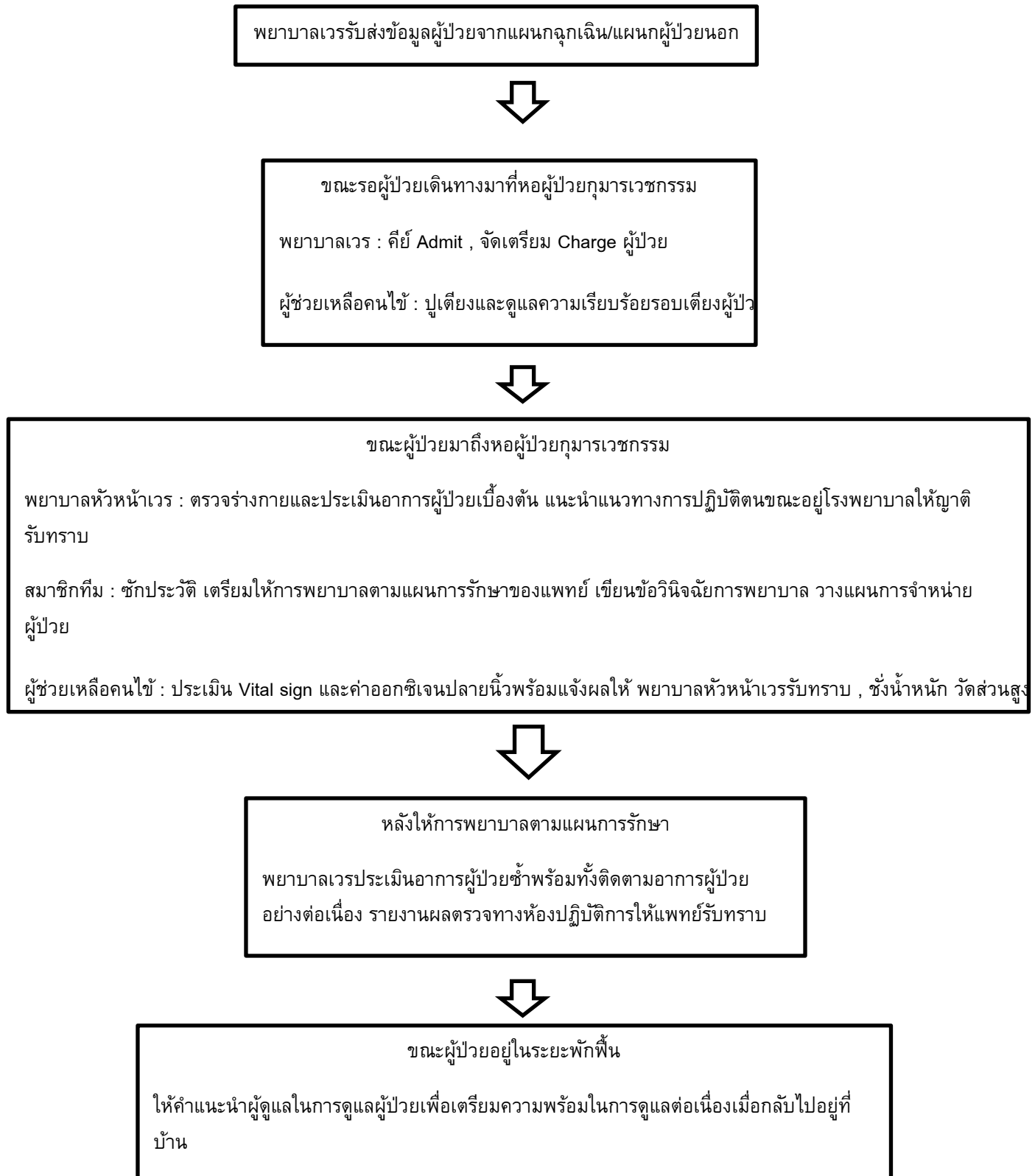
C (Comparators) – กลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติหลังจำหน่ายเด็กจากโรงพยาบาล

O (Outcome) – ผู้ป่วยมีความปลอดภัยหลังได้รับการดูแลรักษา ตามแผนการรักษา

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า1/.....
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วย Acute Gastroenteritis	รหัสเอกสาร CNPG-.....

6. วิธีดำเนินการ (หรือProcedures)

6.1 Flow chart ระบบงาน



	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า1/.....
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วย Acute Gastroenteritis	รหัสเอกสาร CNPG-.....

6.2 ขั้นตอนแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก

ผู้ป่วยอยู่ในระยะระยะกึ่งวิกฤต มีข้อวินิจฉัยการพยาบาล ดังนี้

ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 1 มีภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร

ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 2 มีภาวะ Electrolyte Imbalance

ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 3 มีโอกาสเกิดภาวะขาดสารอาหาร เนื่องจากรับประทานอาหารได้น้อย

ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 4 บิดามารดาวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย

ผู้ป่วยอยู่ในระยะฟื้นฟูสภาพ มีข้อวินิจฉัยการพยาบาล ดังนี้

ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 5 วางแผนการจำหน่ายตามหลัก D-METHOD

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า1/.....
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วย Acute Gastroenteritis	รหัสเอกสาร CNPG-.....

ผู้ป่วยอยู่ในระยะระยะกึ่งวิกฤต มีข้อวินิจฉัยการพยาบาล ดังนี้
 ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 1 มีภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร

ข้อมูลสนับสนุน	วัตถุประสงค์ ทางการพยาบาล	เกณฑ์การประเมินผล	กิจกรรมการพยาบาล	กองทุนที่เกี่ยวข้อง
S (Subjective data) - จำนวนครั้งของการอาเจียน/ อุจจาระเหลว - ชนิดของอาหารที่ผู้ป่วย รับประทาน - ลักษณะของอุจจาระ O (Objective data) - สัญญาณชีพ BT>37.8 C , Pulse เบาเร็ว , BP drop - ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ CBC , Elyte , Stool exam , Stool culture	ผู้ป่วยอาการทุเลา ไม่เกิด ภาวะแทรกซ้อน	1. อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.8 องศาเซลเซียส 2. ลักษณะอุจจาระปกติ ไม่ มีมูก ไม่มีเลือดปน 3. ผู้ป่วยไม่มีมีอาการอาเจียน/ ถ่ายเหลวเพิ่ม	1. ดูแลให้สารน้ำทดแทนตามแผนการ รักษา. 2. เก็บส่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ติดตามผลการตรวจและรายงาน แพทย์ 3. ประเมินระดับของภาวะขาดน้ำ 4. ดูแลให้ยาปฏิชีวนะตามแผนการ รักษา 5. แนะนำผู้ดูแลเรื่องสุขอนามัย แนะนำผู้ป่วยและญาติล้างมือบ่อยๆ ผู้ป่วยที่ใช้ขวดนม ให้ล้างและึ่งขวด นมทุกครั้งก่อนการใช้งาน 6. ดูแลให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารอ่อน	1. กองทุน UC 2. ต่างด้าวซื้อประกัน 3. ต่างด้าวจ่ายเงิน

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า1/.....
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วย Acute Gastroenteritis	รหัสเอกสาร CNPG-.....

ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 2 มีภาวะ Electrolyte Imbalance

ข้อมูลสนับสนุน	วัตถุประสงค์ทางการพยาบาล	เกณฑ์การประเมินผล	กิจกรรมการพยาบาล	กองทุนที่เกี่ยวข้อง
S (Subjective data) - ผู้ป่วยอ่อนเพลีย ซึมลง ปากแห้ง ตาโหล กระหม่อมบวม ผิวแห้ง - GCS Score น้อยกว่า 15 คะแนน O (Objective data) - ผล Electrolyte มีค่าผิดปกติ	ผู้ป่วยได้รับสารน้ำทดแทน ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน	ผล Electrolyte มีค่าปกติ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการสูญเสียสารน้ำในร่างกาย	1. ประเมินระดับของภาวะขาดน้ำ 2. เก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 3. ดูแลให้สารน้ำทดแทนตามแผนการรักษาทั้งทางปากและทางหลอดเลือดดำ 4. ดูแลให้ยาบรรเทาอาการอาเจียน/ถ่ายเหลว 5. ประเมินอาการหลังให้การพยาบาลและรายงานแพทย์	1. กองทุน UC 2. ต่างด้าวซื้อประกัน 3. ต่างด้าวจ่ายเงิน

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า1/.....
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วย Acute Gastroenteritis	รหัสเอกสาร CNPG-.....

ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 3 มีโอกาสเกิดภาวะขาดสารอาหาร เนื่องจากรับประทานอาหารได้น้อย

ข้อมูลสนับสนุน	วัตถุประสงค์ทางการพยาบาล	เกณฑ์การประเมินผล	กิจกรรมการพยาบาล	กองทุนที่เกี่ยวข้อง
S (Subjective data) - ผู้ป่วยอ่อนเพลีย - ญาติผู้ป่วยให้ข้อมูล รับประทานอาหารได้น้อย O (Objective data) - น้ำหนักตัวลดลงจากเดิม	ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะขาดสารอาหาร	น้ำหนักตัวผู้ป่วยคงที่ รับประทานอาหารได้เท่า ปริมาณปกติก่อนมี อาการป่วย	1. แนะนำรับประทานอาหารอ่อน ย่อย ง่าย หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด และอาการสุก ๆ ดิบ ๆ 2. ในผู้ป่วยเด็กที่รับประทานนม แนะนำ นม lactose free ในช่วงที่ผู้ป่วยมีอาการ ท้องเสียถ่ายเหลว 3. ชั่งน้ำหนักตัวสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 4. ดูแลทำความสะอาดช่องปาก แปรงฟัน ก่อนรับประทานอาหาร เพื่อกระตุ้นความ อยากอาหาร	1. กองทุน UC 2. ต่างด้าวซื้อประกัน 3. ต่างด้าวจ่ายเงิน

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า1/.....
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วย Acute Gastroenteritis	รหัสเอกสาร CNPG-.....

ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 4 บิดามารดามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย

ข้อมูลสนับสนุน	วัตถุประสงค์ทางการพยาบาล	เกณฑ์การประเมินผล	กิจกรรมการพยาบาล	กองทุนที่เกี่ยวข้อง
S (Subjective data) - ญาติสอบถามอาการผู้ป่วย O (Objective data) - ญาติมีสีหน้ากังวล	ญาติผู้ป่วยคลายความกังวล รับทราบเข้าใจแผนการรักษา	ญาติผู้ป่วยมีสีหน้าวิตกกังวลลดลง	1. ประเมินความวิตกกังวลของญาติและสร้างสัมพันธภาพ 2. ให้ญาติได้ระบายความรู้สึกและซักถามข้อมูลที่สงสัย 3. แนะนำการปฏิบัติตนขณะอยู่ในโรงพยาบาล 4. ให้กำลังใจญาติ สร้างความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย	1. กองทุน UC 2. ต่างตัวซื้อประกัน 3. ต่างตัวจ่ายเงิน

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า1/.....
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วย Acute Gastroenteritis	รหัสเอกสาร CNPG-.....

ผู้ป่วยอยู่ในระยะฟื้นฟูสภาพ มีข้อวินิจฉัยการพยาบาล ดังนี้

ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 5 วางแผนการจำหน่ายตามหลัก D-METHOD

ข้อมูลสนับสนุน	วัตถุประสงค์ทางการพยาบาล	เกณฑ์การประเมินผล	กิจกรรมการพยาบาล	กองทุนที่เกี่ยวข้อง
S (Subjective data) - ผู้ป่วยอาการทุเลาเป็นผู้ป่วยประเภท 2 - แพทย์ Plan D/C O (Objective data) - สัญญาณชีพผู้ป่วยคงที่	ญาติมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน	ผู้ดูแลสามารถตอบคำถามย้อนกลับในการดูแลผู้ป่วยเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านได้ถูกต้อง ร้อยละ 100	1. สอบถามข้อมูลการดูแลผู้ป่วยตามจริง 2. ให้ข้อมูลการเตรียมตัวและการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านตามหลัก D-METHOD 3. ถามคำถาม และให้ผู้ดูแลตอบคำถามย้อนกลับ	1. กองทุน UC 2. ต่างด้าวซื้อประกัน 3. ต่างด้าวจ่ายเงิน

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า1/.....
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วย Acute Gastroenteritis	รหัสเอกสาร CNPG-.....

องค์ประกอบของหลัก D-METHOD

D – Diagnosis (โรค) : ให้ความรู้เรื่องโรค สาเหตุ อาการ และการปฏิบัติตัว

M – Medication (ยา) : แนะนำเรื่องยาที่ได้รับ สรรพคุณ วิธีใช้ ข้อควรระวัง และภาวะแทรกซ้อน

E – Environment & Economic (สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ) : จัดการสภาพแวดล้อมที่บ้านให้เหมาะสม รวมถึงดูแลปัญหาด้านเศรษฐกิจ

T – Treatment (การรักษา) : ทักษะการรักษาต่อเนื่อง เช่น การทำแผล การเฝ้าสังเกตอาการผิดปกติ

H – Health (สุขภาพ) : การส่งเสริมฟื้นฟูร่างกาย และจิตใจ การออกกำลังกาย

O – Outpatient (การตรวจตามนัด) : นัดตรวจ การติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน และการดูแลในภาวะฉุกเฉิน

D – Diet (อาหาร) : การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรค และข้อจำกัด

แนวทางการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรค Acute Gastroenteritis โดยใช้หลัก D-METHOD

D – Diagnosis (โรค) : ให้ความรู้เรื่องโรค สาเหตุ อาการ และการปฏิบัติตัว

สาเหตุ

สาเหตุของโรคท้องร่วงเฉียบพลันในเด็กมักเกิดจากการติดเชื้อเป็นส่วนใหญ่ มีส่วนน้อยที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น ยาปฏิชีวนะ (antibiotic-associated diarrhea) อาการไม่พึงประสงค์ของยาบางชนิด หรือเกิดจากการกินอาหารบางชนิด ส่วนใหญ่พบสาเหตุจากการติดเชื้อ เชื้อก่อโรคที่พบบ่อย ได้แก่ เชื้อไวรัสและแบคทีเรีย มีส่วนน้อยที่สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อโปรโตซัวและหนอนพยาธิ

สาเหตุของท้องร่วงเฉียบพลันจำแนกตามลักษณะอาการ

เชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงเฉียบพลันจำแนกตามลักษณะอาการ สามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ อูจจาระเป็นน้ำ และอูจจาระเป็นมูกหรือมูกปนเลือด

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า1/.....
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วย Acute Gastroenteritis	รหัสเอกสาร CNPG-.....

1. อุจจาระเป็นน้ำ มักมีพยาธิสภาพที่ลำไส้เล็ก ผู้ป่วยมาด้วยอาการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำปริมาณมาก ผู้ป่วยมักไม่มีไข้หรือมีไข้ต่ำ ๆ แต่ในผู้ป่วยเด็กที่องรงจากเชื้อ rotavirus อาจพบไข้สูงได้ การตรวจอุจจาระมักไม่พบเม็ดเลือดขาวหรือพบได้น้อยมาก

2. อุจจาระเป็นมูกหรือมูกปนเลือด เกิดจากการรกล้ำของเชื้อเข้าไปในเยื่อลำไส้หรือมีการสร้าง cytotoxin ทำให้เกิดแผลอักเสบและเซลล์ตาย มักมีพยาธิสภาพที่ลำไส้ใหญ่ มีการถ่ายอุจจาระปริมาณไม่มากในแต่ละครั้ง แต่มักถ่ายอุจจาระบ่อย มีอาการปวดเบ่งเหมือนถ่ายไม่สุด (tenesmus) ซึ่งบ่งชี้ถึงการอักเสบที่บริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหรือไส้ตรง (rectum) ผู้ป่วยมักมีไข้ร่วมด้วย ตรวจพบเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ เชื้อก่อโรคในกลุ่มนี้หลายชนิดสามารถสร้าง enterotoxin ทำให้มีอาการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำในช่วงแรกแล้วจึงถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือดตามมาได้

อาการ และอาการแสดง

มีไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส อุจจาระเป็นมูกหรือมูกเลือดหรือมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง ถ่ายเป็นน้ำอย่างรุนแรงและปริมาณมากคล้ายน้ำข้าวข้าว มีอาการซึม กระสับกระส่าย ปากแห้ง ปัสสาวะออกน้อยลง

การปฏิบัติตัว : ให้คำแนะนำญาติผู้ดูแลผู้ป่วย เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ

- แนะนำการดูแลสุขอนามัยของผู้ป่วยเด็กและผู้ดูแล โดยให้ผู้ดูแลสอนเด็กล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุง หรือรับประทานอาหาร

- แนะนำผู้ดูแลจัดให้ผู้ป่วยเด็กรับประทานอาหารที่สะอาดและสุกใหม่และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ค้างคืน ให้ดื่มน้ำที่สะอาดหรือน้ำต้มสุก ผักสดหรือผลไม้ ควรล้างให้สะอาดด้วยน้ำยาล้างผัก น้ำด่างทับทิม เป็นต้น และควรมีภาชนะปกปิดอาหารป้องกันแมลงวันตอม

- ในผู้ป่วยวัยทารก แนะนำให้ทานนมมารดาได้ตามปกติ ทารกที่กินนมผสมและอาหารตามวัยอื่น ๆ แนะนำให้เริ่มกินนมและอาหาร ไม่เกิน 4-6 ชั่วโมงแรก หลังจากเริ่มรักษาภาวะขาดน้ำ ไม่ควรงดนมหรือกินนมผสมเฉยๆ ทารกและเด็กเล็กที่ไม่ได้กินนมมารดา และถ่ายอุจจาระเป็นน้ำรุนแรงที่สงสัยภาวะ lactose intolerance หรือรับการรักษาในโรงพยาบาล อาจพิจารณาเปลี่ยนนมเป็นนมสูตรที่ปราศจากน้ำตาลแล็กโทส

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า1/.....
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วย Acute Gastroenteritis	รหัสเอกสาร CNPG-.....

- แนะนำให้กินอาหารตามวัยที่ง่ายขึ้น ไม่ต้องงดอาหาร โดยให้กินในปริมาณน้อย ๆ และกินบ่อย ๆ
 ควรดื่มน้ำที่สะอาด

M – Medication (ยา) : แนะนำเรื่องยาที่ได้รับ สรรพคุณ วิธีใช้ ข้อควรระวัง และภาวะแทรกซ้อน

ยา Home Medication ที่แพทย์สั่งใช้ในหอผู้ป่วยเด็ก

- Domperidone (ชื่อการค้า : Motilium) เป็นยาที่ออกฤทธิ์เพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร ใช้บรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน โดยรับประทานทางปาก ก่อนอาหาร ระยะเวลาที่ใช้ยาควรสั้นที่สุดตามความจำเป็น (ไม่ควรใช้ต่อเนื่องเกิน 7 วัน) และไม่แนะนำให้รับประทานยาบ่อยหรือใช้ในระยะเวลา ยานี้มี อาการไม่พึงประสงค์หลายอย่างรวมถึงอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งอาจเกิดได้รุนแรง หากมีอาการท้องอืด เกิดขึ้นแนะนำให้หยุดรับประทานหรือลุกขึ้นเดิน โดยเฉพาะหลังรับประทานยา ไม่ควรรับประทานยาแต่ ละมือจนอิ่มเกินไป ควรรับประทานน้อยลงแต่อาจบ่อยขึ้น รับประทานยาที่ง่ายและเคี้ยวอาหารให้ ละเอียดก่อนกลืน หากอาการยังไม่ดีขึ้นหรือมีแนวโน้มแย่ลงควรพบแพทย์

Smecta (สเม็คตา) เป็นชื่อทางการค้าของยาที่มีตัวยาคือ Diosmectite (ไดออสเมกไทต์) หรือ Dioctahedral smectite ซึ่งเป็นผงดินเหนียวธรรมชาติ ใช้สำหรับรักษาอาการท้องเสียทั้งเฉียบพลันและ เรื้อรัง โดยยาจะช่วยเคลือบเยื่อลำไส้และจับสารพิษ นอกจาก Smecta แล้ว ยังมียาชื่อการค้าอื่นที่มีตัวยาคือ เดียกานคือ Dehecta (ดีเฮกต้า)

ประกอบด้วยตัวยาคือ Dioctahedral Smectite 3 g ต่อซอง โดยยานี้ใช้สำหรับอาการท้องเสีย มีคุณสมบัติช่วยเคลือบทางเดินอาหาร และช่วยเพิ่มความต้านทานให้แก่ชั้นเมือกโดยทำปฏิกิริยากับ glycoprotein ในชั้นเมือก และออกฤทธิ์ปกป้องเยื่อเมือกของระบบทางเดินอาหาร ดักจับไม่ให้สารพิษหรือ สิ่งแปลกปลอมหลุดเข้าไปสู่กระแสเลือด สามารถใช้ได้ทั้งท้องเสียแบบเฉียบพลันและท้องเสียแบบเรื้อรัง โดย คุณสมบัติเด่นคือยาจะไม่ถูกดูดซึมจากทางเดินอาหาร ทำให้ออกฤทธิ์บริเวณทางเดินอาหารได้เป็นอย่างดีและ จะถูกขับออกทางอุจจาระ ข้อแตกต่างระหว่าง Smecta กับ Dehecta คือรูปแบบของยา โดย Smecta จะอยู่ ในรูปแบบผงใช้ชงกับน้ำปริมาณ 50 มิลลิลิตร (รสส้มผสมวานิลลา) แต่ Dehecta จะอยู่ในรูปแบบยาน้ำแขวน ตะกอน 20 มิลลิลิตร ทำให้สะดวกกว่าในแง่ของการรับประทาน สามารถฝึกชงดื่มได้เลย (รสวานิลลาผสมสตอ เบอรี่)

ขนาดยาที่แนะนำทั้ง 2 รูปแบบเหมือนกันคือ

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า1/.....
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วย Acute Gastroenteritis	รหัสเอกสาร CNPG-.....

- ในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ให้รับประทาน 1 ซอง โดยแบ่งให้วันละ 2 ครั้ง
- ในเด็กอายุ 1-2 ปี ให้รับประทาน 1-2 ซอง โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
- ในเด็กอายุ 2 ขึ้นไป ให้รับประทาน 2-3 ซอง โดยแบ่งให้วันละ 2-3 ครั้ง
- ผู้ใหญ่ ให้รับประทานครั้งละ 1 ซอง วันละ 3-4 ครั้ง

ในกรณีท้องเสียเฉียบพลัน เมื่อเริ่มการรักษาอาจให้ยาเป็น 2 เท่าของขนาดปกติ ควรให้ยาระหว่างมื้ออาหาร หลังรับประทานยาทั้งสองยี่ห้อควรดื่มน้ำตาม หรือสามารถไชยาร่วมกับของกึ่งเหลว เช่น น้ำซूप อาหารทารก เป็นต้น แต่ ****ไม่ควรรับประทานยาร่วมกับยาอื่น**** เนื่องจากจะมีผลต่อการดูดซึมยาอื่นทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลง ควรเว้นห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ควรทดแทนด้วยเกลือแร่เพื่อป้องกันอาการขาดน้ำโดยเฉพาะในเด็กเล็ก

ผลข้างเคียงที่พบ ได้แก่ อาการท้องผูก (พบน้อย) แก้โดยการลดขนาดยาและหากมีอาการอื่นนอกเหนือจากนี้ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ส่วนในคนที่มีอาการท้องเสียเรื้อรังนั้น แม้ว่า smecta/dehecta จะมีข้อบ่งใช้สามารถลดการท้องเสียลงได้ แต่ควรแก้จากสาเหตุเป็นหลักเนื่องจากหากท้องเสียเรื้อรังเป็นเวลานานอาจทำให้มีภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมาได้

E – Environment & Economic (สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ) : จัดการสภาพแวดล้อมที่บ้านให้เหมาะสม รวมถึงดูแลปัญหาด้านเศรษฐกิจ

T – Treatment (การรักษา) : ทักษะการรักษาต่อเนื่อง เช่น การทำแผล การเฝ้าสังเกตอาการผิดปกติ

H – Health (สุขภาพ) : การส่งเสริมฟื้นฟูร่างกาย และจิตใจ การออกกำลังกาย

O – Outpatient (การตรวจตามนัด) : นัดตรวจ การติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน และการดูแลในภาวะฉุกเฉิน

D – Diet (อาหาร) : การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรค และข้อจำกัด

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า1/.....
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วย Acute Gastroenteritis	รหัสเอกสาร CNPG-.....

7. เอกสารที่ใช้ในการประเมิน (Records & Form)

7.1 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

การประเมินภาวะ Dehydration ร่วมกับการตรวจร่างกายอื่น ๆ ตาม CDC Scale

ความรุนแรง	น้อย 3-5%	ปานกลาง 6-9%	มาก >10%
Mental status	ปกติ รู้สึกตัวดี	ปกติ อ่อนเพลีย กระสับกระส่าย	Apathetic ซึม ไม่รู้สึกตัว
การกระหายน้ำ	เล็กน้อย	ปานกลาง	มาก
อัตราการเต้นของหัวใจ	ปกติ	ปกติถึงเพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น ในรายที่รุนแรงมากอาจมีหัวใจเต้นช้า
คุณภาพของซีพจร	ปกติ	ปกติถึงลดลง	เบาหรือคลำไม่ได้
การหายใจ	ปกติ	ปกติหรือเร็ว	หอบลึก
ความดันโลหิต	ปกติ	ปกติหรือต่ำลงมากกว่า 10 mmHg	ต่ำ หน้ามืด Pulse Pressure < 20 mmHg
ตา	ปกติ	ลึกละเอียดเล็กน้อย	ลึกละเอียดมาก
น้ำตา	มีน้ำตา	ลดลง	ไม่มีน้ำตา ตาลึกละเอียด
ปากและลิ้น	ปกติ	แห้ง	แห้งมาก
Skin fold	Recoil ทันที	Recoil ในเวลา < 2 วินาที	Recoil ในเวลา > 2 วินาที
Urine output	ปกติหรือลดลงเล็กน้อย	1 mL/kg/hr	ไม่ออก / 0.5 mL/kg/hr
Capillary refill	< 2 วินาที	2-3 วินาที	3-4 วินาที

การประเมินภาวะ Dehydration โดยการคำนวณน้ำหนักผู้ป่วย

$$\frac{\text{น้ำหนักที่ลดลง (น้ำหนักปัจจุบัน)}}{\text{น้ำหนักเดิม}} \times 100$$

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า1/.....
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วย Acute Gastroenteritis	รหัสเอกสาร CNPG-.....

8. เอกสารอ้างอิง (หรือ References) ตาม APA 6th พร้อมเขียนอ้างอิงในเอกสาร

ปราณี ทัพพะเวระ. (2564). คู่มือยา (HANDBOOK OF DRUGS). พิมพ์ครั้งที่ 15. กรุงเทพฯ: N P Press Limited Partnership 826/266.

สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ. (2562). แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรค
 ท้องร่วงเฉียบพลันในเด็ก Clinical Practice Guideline for Acute Diarrhea in Children.
 สืบค้นเมื่อ วันที่ 28 มีนาคม 2567 จาก:
https://www.pthaigastro.org/Document/hz0tpx1bdldozf11z5minfimCPG_Blue.pdf

พัชรพร คำภูมิ. (2564). ผลของการพยาบาลอย่างต่อเนื่องต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 5
 ปี โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันของผู้ดูแล. คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สืบค้นเมื่อ
 วันที่ 28 มีนาคม 2567 จาก:
<https://digital.car.chula.ac.th/cgi/viewcontent.cgi?article=6301&context=chulaetd>